

Einen älteren autistischen Erwachsenen / eine ältere autistische Erwachsene, den/die Sie zu Hause begleiten

Für häusliche Betreuungskräfte, persönliche Assistenzkräfte und Gemeinden-Unterstützungspersonal — einen älteren autistischen Erwachsenen unterstützen (etwa 60+).

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit eines älteren Erwachsenen schon immer in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ eingeschlossen hat. Viele ältere autistische Erwachsene wurden nie erkannt und tragen ein Leben lang Masking und unerfüllten Bedarf. Ihre Besuche sind vielleicht die vorhersagbarste, akzeptierendste Beziehung in ihrer Woche. Schützen Sie lebenslange Routinen, Interessen und Objekte; senken Sie die sensorische Last; kommunizieren Sie wörtlich; und achten Sie auf das Burnout und den Schmerz, den „nicht klagen“ verbergen kann.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
Jeden Besuch dieselbe Routine, Objekte, Interessen	Vorhersagbarkeit und Flow sind Regulation und Identität
Meidet Versorgung, sagt ab, „mag es nicht, wenn Sie kommen“	Lebenslange negative Erfahrungen + sensorische/Kommunikations-Barrieren
Langsame, ungewöhnliche Antworten; scheint verwirrt	Oft Verarbeitungszeit + autistischer Unterschied — nicht notwendigerweise Demenz
Meldet keinen Schmerz oder keine Symptome	Interozeptions -Unterschiede; „nicht klagen“ ≠ „nicht leiden“
Zurückgezogen, erschöpft	Möglicherweise über Jahrzehnte akkumuliertes Burnout

Versuchen Sie dies

- **Seien Sie die vorhersagbare, akzeptierende Präsenz** — dieselbe Person, dieselbe Zeit, derselbe Plan; warnen Sie vor jedem Wechsel.
- **Schützen Sie lebenslange Routinen, Interessen und Objekte** — sie „zur Sicherheit“ zu entfernen, kann echten Schaden anrichten.
- **Kommunizieren Sie klar, wörtlich und langsam**, schriftlich, wo es hilft; gewähren Sie reichlich Verarbeitungszeit.
- **Senken Sie die sensorische Last** und berücksichtigen Sie Hör-/Sehveränderungen, die lebenslange Unterschiede verstärken.
- **Fragen Sie proaktiv nach Schmerz und Symptomen** — warten Sie nicht, bis sie es erwähnen.

Vermeiden Sie dies

- Routinen stören oder vertraute Objekte entfernen.
- Annehmen, Langsamkeit oder ein anderer Stil bedeute kognitiven Rückgang — untersuchen Sie, unterstellen Sie nichts.
- Leise oder eine „gefestigte“ Präsentation mit „gesund sein“ gleichsetzen.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Achten Sie auf **autistisches Burnout** (oft über Jahrzehnte im Entstehen) und **soziale Isolation** (ein Hauptrisiko). Die Frage **Demenz-oder-Unterschied?** ist schwer und untererforscht — kennzeichnen Sie Veränderungen unterstützend und suchen Sie autismus-informierte Abklärung statt anzunehmen. Melden Sie jede neue Belastung als mögliches medizinisches Warnsignal.

Wenn die Person eine Frau ist

Ältere autistische Frauen sind eine besonders unter-erkannte Gruppe, die ein Leben lang gemaskt hat; eine Geschichte von „Angst“ oder Burnout neben lebenslangen Unterschieden rechtfertigt ernsthafte Erwägung von Autismus.

Über diesen Leitfaden

*KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für die **Familie** (Teil 5), der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teil 3.5) und das **Monotropismus**-Dossier. Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein diagnostisches Werkzeug**. Die Evidenz im Alter ist dünn; passen Sie es an die einzelne Person an.*

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Klein et al. (2024, Altern & Autismus); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024); OAR (Altern im Spektrum). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.